

RECEITA MÉDICA

Médico: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 26/02/2026 13:25

Paciente: Sukadas

Idade: 26 anos

Gênero: masculino

1. DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME: Exame de Sangue Completo --- DESCRIÇÃO: NM --- RESULTADO: **Relatório de Análise de Esfregaço de Sangue Periférico** **Informações do Paciente:** * Nome: Sukadas * Idade: 26 anos * Gênero: Masculino * Tipo de exame: Exame de Sangue Completo * Urgência Inicial do Pedido: NORMAL --- **1. Descrição da imagem e qualidade técnica:** A imagem apresenta uma micrografia de um esfregaço de sangue periférico corado por uma técnica tipo Romanowsky (ex: Giemsa, Wright). A qualidade técnica da imagem é satisfatória, com bom foco e iluminação uniforme, o que permite uma análise detalhada da morfologia das células sanguíneas e a identificação de estruturas intracelulares. A magnificação é adequada para a visualização das hemácias e seus conteúdos. **2. Achados principais:** **Hemácias:** Observa-se uma população de hemácias com variação de tamanho (anisocitose) e forma (poiquilocitose). Algumas hemácias apresentam hipocromia (centro pálido aumentado) e são microcíticas (tamanho reduzido), características que sugerem uma anemia. Também são visíveis algumas hemácias com formas alteradas, como células em alvo (codócitos) e, possivelmente, algumas dacriócitos (células em lágrima). * **Parasitas Intracelulares:** O achado mais proeminente e patognomônico é a presença de múltiplos parasitas intracelulares dentro das hemácias. Estes parasitas se apresentam predominantemente como formas em anel (trofozoítos jovens), corando-se de roxo escuro, e alguns podem exibir um ou múltiplos pontos de cromatina. A carga parasitária é notável em algumas áreas do campo visual. * **Leucócitos e Plaquetas:** Não é possível fazer uma avaliação completa dos leucócitos ou plaquetas a partir desta única imagem, embora algumas plaquetas sejam visíveis no fundo. **3. Diagnóstico sugerido:** Com base na presença de parasitas intracelulares em hemácias, o diagnóstico mais provável é **Malária**. A morfologia dos parasitas (formas em anel pequenas, com pontos de cromatina por vezes múltiplos, e a ausência aparente de estágios mais maduros como esquizontes grandes ou gametócitos de outras espécies neste campo) é altamente sugestiva de infecção por **Plasmodium falciparum**. A anemia microcítica e hipocrômica observada é uma complicação comum da malária, embora outras causas também devam ser consideradas. **4. Recomendações:** **Confirmação da Espécie e Quantificação:** É crucial realizar uma contagem de parasitemia (percentual de hemácias parasitadas) e uma busca minuciosa em múltiplos campos da lâmina para identificar e confirmar a espécie exata de *Plasmodium*. A identificação de gametócitos ou esquizontes maduros pode ser decisiva. Testes moleculares (ex: PCR) podem ser considerados para confirmação e para detectar infecções mistas. * **Correlação Clínica Urgente:** Este achado deve ser correlacionado imediatamente com o quadro clínico do paciente (sintomas como febre, calafrios, sudorese, cefaleia, mialgia) e seu histórico de viagem recente para áreas endêmicas de malária. * **Exames Laboratoriais Complementares:** * Hemograma completo: Para avaliar a gravidade da anemia (níveis de hemoglobina e hematócrito, índices de glóbulos vermelhos) e monitorar a contagem de plaquetas e leucócitos. * Bioquímica sanguínea: Avaliação da função hepática e renal, eletrólitos, glicemia, devido ao potencial de comprometimento orgânico na malária. * **Início Imediato de Tratamento:** Dada a alta suspeita de *Plasmodium falciparum*, que é a espécie mais virulenta e potencialmente fatal, o tratamento antimalárico adequado deve ser iniciado sem demora, conforme as diretrizes nacionais e internacionais. **5. Nível de urgência:** **Alta (High)**. Embora a solicitação inicial do

exame tenha sido classificada como "NORMAL", a descoberta de parasitas de malária, especialmente com a forte suspeita de *Plasmodium falciparum*, representa uma condição de saúde que exige intervenção médica imediata para prevenir o desenvolvimento de malária grave e complicações potencialmente fatais. --- **DIAGNÓSTICO PRELIMINAR:** ****Relatório de Análise de Esfregaço de Sangue Periférico**** ****Informações do Paciente:**** * Nome: Sukadas * Idade: 26 anos * Gênero: Masculino * Tipo de exame: Exame de Sangue Completo * Urgência Inicial do Pedido: NORMAL --- ****1. Descrição da imagem e qualidade técnica:**** A imagem apresenta uma micrografia de um esfregaço de sangue periférico corado por uma técnica tipo Romanowsky (ex: Giemsa, Wright). A qualidade técnica da imagem é satisfatória, com bom foco e iluminação uniforme, o que permite uma análise detalhada da morfologia das células sanguíneas e a identificação de estruturas intracelulares. A magnificação é adequada para a visualização das hemácias e seus conteúdos. ****2. Achados principais:**** ****Hemácias:**** Observa-se uma população de hemácias com variação de tamanho (anisocitose) e forma (poiquilocitose). Algumas hemácias apresentam hipocromia (centro pálido aumentado) e são microcíticas (tamanho reduzido), características que sugerem uma anemia. Também são visíveis algumas hemácias com formas alteradas, como células em alvo (codócitos) e, possivelmente, algumas dacriócitos (células em lágrima). ****Parasitas Intracelulares:**** O achado mais proeminente e patognomônico é a presença de múltiplos parasitas intracelulares dentro das hemácias. Estes parasitas se apresentam predominantemente como formas em anel (trofozoítos jovens), corando-se de roxo escuro, e alguns podem exibir um ou múltiplos pontos de cromatina. A carga parasitária é notável em algumas áreas do campo visual. ****Leucócitos e Plaquetas:**** Não é possível fazer uma avaliação completa dos leucócitos ou plaquetas a partir desta única imagem, embora algumas plaquetas sejam visíveis no fundo. ****3. Diagnóstico sugerido:**** Com base na presença de parasitas intracelulares em hemácias, o diagnóstico mais provável é ****Malária****. A morfologia dos parasitas (formas em anel pequenas, com pontos de cromatina por vezes múltiplos, e a ausência aparente de estágios mais maduros como esquizontes grandes ou gametócitos de outras espécies neste campo) é altamente sugestiva de infecção por ****Plasmodium falciparum****. A anemia microcítica e hipocrômica observada é uma complicação comum da malária, embora outras causas também devam ser consideradas. ****4. Recomendações:**** ****Confirmação da Espécie e Quantificação:**** É crucial realizar uma contagem de parasitemia (percentual de hemácias parasitadas) e uma busca minuciosa em múltiplos campos da lâmina para identificar e confirmar a espécie exata de *Plasmodium*. A identificação de gametócitos ou esquizontes maduros pode ser decisiva. Testes moleculares (ex: PCR) podem ser considerados para confirmação e para detectar infecções mistas. ****Correlação Clínica Urgente:**** Este achado deve ser correlacionado imediatamente com o quadro clínico do paciente (sintomas como febre, calafrios, sudorese, cefaleia, mialgia) e seu histórico de viagem recente para áreas endêmicas de malária. ****Exames Laboratoriais Complementares:**** * Hemograma completo: Para avaliar a gravidade da anemia (níveis de hemoglobina e hematócrito, índices de glóbulos vermelhos) e monitorar a contagem de plaquetas e leucócitos. * Bioquímica sanguínea: Avaliação da função hepática e renal, eletrólitos, glicemia, devido ao potencial de comprometimento orgânico na malária. ****Início Imediato de Tratamento:**** Dada a alta suspeita de *Plasmodium falciparum*, que é a espécie mais virulenta e potencialmente fatal, o tratamento antimalárico adequado deve ser iniciado sem demora, conforme as diretrizes nacionais e internacionais. ****5. Nível de urgência:**** ****Alta (High)****. Embora a solicitação inicial do exame tenha sido classificada como "NORMAL", a descoberta de parasitas de malária, especialmente com a forte suspeita de *Plasmodium falciparum*, representa uma condição de saúde que exige intervenção médica imediata para prevenir o desenvolvimento de malária grave e complicações potencialmente fatais.

2. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

****TRATAMENTO PARA MALARIA NAO COMPLICADA****

Artemeter + Lumefantrina (ACT)

* Apresentação: Comprimidos 20/120mg

* Posologia: Dose baseada no peso: 1-4 comprimidos por dose

* Frequência: 2 vezes ao dia

* Duração: 3 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 24 comprimidos (esquema de 6 doses)

* Terapia Combinada à Base de Artemisinina (ACT) - primeira linha OMS

Primaquina

* Apresentação: Comprimidos 15mg

* Posologia: 0,5mg/kg/dia

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 14 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 14 comprimidos

* APÓS teste G6PD - para eliminar formas hepáticas do P. vivax

3. RECOMENDAÇÕES MÉDICAS

- Seguir rigorosamente a posologia dos medicamentos prescritos
- Manter-se bem hidratado, ingerindo bastante líquidos
- Repousar adequadamente para auxiliar na recuperação
- Evitar automedicação e bebidas alcoólicas durante o tratamento
-

■■■ SINAIS DE ALERTA - PROCURAR URGÊNCIA SE:

- Febre persistente ou alta (>24h sem melhora)
- Falta de ar ou dificuldade para respirar
- Confusão mental, sonolência excessiva ou desmaios
- Sangramentos incomuns (gengivas, nariz, urina escura)
- Vômitos persistentes, impossibilidade de ingerir líquidos
- Dor abdominal intensa
-

Retorno: Agendar em 7-10 dias ou antes se necessário

Assinatura do Médico

fernando

CRM: sfgh

Validade: 30 dias

fernando

CRM: sfgh

Validade: 30 dias